Anamnesefragen

Was kann ich für Sie tun?
Was führt Sie zu uns?

Seit wann haben Sie Husten?
Ist der Husten trocken oder mit Auswurf?
Welche Farbe und Konsistenz hat der Auswurf?
Gibt es Blut im Auswurf?

Ist der Husten dauerhaft da, oder kommt er in Attacken?

Ist es das erste Mal, oder hatten Sie früher schon ähnliche Symptome?(burda sormak öksürük atakalrı ile giden hastalıkları dışlamak için önemli)

Haben Sie dabei Luftnot?
Tritt die Luftnot bei Belastung oder auch in Ruhe auf?
Wird es schlimmer, wenn Sie sich hinlegen?

Haben sie bemerkt, dass Sie geschwollene, görötete oder überwarmte Beinen haben?

Haben sie sich an Brustkorb verletz?

Haben Sie Brustschmerzen oder Herzklopfen im Zusammenhang?
Wo genau tut es weh?
Seit wann?
Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?
Gibt es bestimmte Auslöser?
Sind die Schmerzen dauerhaft, oder kommen und gehen sie?
Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus, z. B. in den Hals?
Sind die Schmerzen im Verlauf schlimmer geworden?
Können Sie die Schmerzen genauer beschreiben?
Wie stark sind die Schmerzen?
Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt oder lindert, z. B. eine bestimmte Körperhaltung?
Haben Sie etwas gegen die Schmerzen eingenommen?

Haben Sie Fieber?
Haben Sie die Temperatur gemessen?
Wie hoch war sie?
Wo haben Sie gemessen?

Haben Sie Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen oder Muskelschmerzen?
Fühlen Sie sich müde oder abgeschlagen?
Haben Sie pfeifende Atemgeräusche bemerkt?
Haben Sie Geschmacks- oder Geruchsverlust bemerkt?

Gab es in letzter Zeit jemanden in Ihrer Umgebung, der ähnliche Symptome hatte oder krank war?

Sind Sie zu Ihrem Hausarzt gegangen?
Haben Sie dort eine Diagnose erhalten?

Haben Sie eine Diät gemacht oder mehr Sport getrieben?
Woraus besteht Ihre Wasserkur / Wasserdiät?

Wie sieht Ihre Arbeit aus? Sind Sie Holzstaub ausgesetzt?

Ich habe einen Verdacht auf **Lungenentzündung**. Das ist nicht so schlimm und kann einfach mit Medikamenten behandelt werden. Aber das bleibt nur eine Vermutung, wir sollen weitere Untersuchungen durchführen, um dies zu bestätigen.
Ich werde zuerst Ihren Körper untersuchen, dann werde ich Ihnen etwas Blut abnehmen. Danach werden wir eine Röntgenaufnahme der Lunge machen. Wissen Sie, was das ist?

Röntgen ist ein medizinisches Verfahren zur bildlichen Darstellung von Körperstrukturen wie Knochen, Gefäßen und inneren Organen. Röntgenstrahlen gehen durch Ihre Lungen, um ein Bild zu erstellen. Eine tägliche Röntgenbelastung wäre gefährlich für Ihre Gesundheit, aber es gibt keine Gefahr, wenn Sie nur eine Radiologie pro Jahr durchführen lassen.

CT ist ein Röntgenbild, das viele Schichtaufnahmen von Ihrem Körper macht, um genauere Bilder von innen zu bekommen. Das ist schnell und schmerzfrei

Bronchoskopie: Bei einer Lungenspiegelung wird ein dünner Schlauch durch die Nase in die Lunge eingeführt, um die Atemwege von innen anzusehen. Machen Sie sich keine Sorge, Sie werden nichts spüren, wir machen bevor eine Allgemeinanästhesie / Vollnarkose.

Vorstellung:

ä

Guten Tag, Herr Oberarzt, Frau Oberärztin.
Mein Name ist Sümeyra Firat. Heute habe ich einen neuen Patienten aufgenommen.
Bevor ich meinen Patienten vorstelle, möchte ich Ihnen noch etwas Wichtiges mitteilen:
Ich habe einen Anruf aus dem Labor erhalten. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Müller einen Kaliumwert von **2,6 mmol/L** hat. Dieser Wert ist **deutlich erniedrigt** und entspricht einer **Hypokaliämie**.

Es geht um Herrn Jens Bergner. Er ist 38 Jahre alt, geboren am 08.04.1986, 1,73 m groß und wiegt 80 kg.
Herr Bergner stellt sich bei uns wegen seit 6 Tagen bestehendem Husten vor.
Laut Angaben des Patienten ist der Husten produktiv mit gelblich-grünlichem Sputum.

Er berichtet, dass er seit 3 Tagen Thoraxschmerzen hat. Nach Angaben des Patienten sind die Schmerzen langsam aufgetreten, persistierend, progredient sowie ziehend und stechend.
Die Beschwerden verschlimmern sich im Liegen, während sie sich im Sitzen und Stehen bessern. Er erwähnt, dass die Schmerzen nicht ausstrahlen und die Schmerzintensität bei 6/10 auf der Schmerzskala liegt.

Begleitend klagt er seit 3 Tagen über Dyspnoe, die bewegungsunabhängig ist, Halsschmerzen und Fieber. Die Temperatur betrug gestern axillär 38,7 °C.
Außerdem berichtet er, dass seine Tochter vor einer Woche ähnliche Beschwerden hatte; sie ist inzwischen wieder gesund.
Ein COVID-19-Test wurde durchgeführt und war negativ.

Vegetativ-anamnestisch ergaben sich Insomnie, ein gewollter Gewichtsverlust von 4 kg in 3 Monaten, Müdigkeit und Inappetenz.

Bei der Vorerkrankungsanamnese erwähnte er eine arterielle Hypertonie seit 3 Jahren, die gut eingestellt ist (letzte Messung vor 4 Tagen: 130/80 mmHg), sowie Z. n. Orchidopexie und Z. n. Appendektomie.
Bei der Medikamentenanamnese ergab sich die Einnahme von Ramipril 5 mg (1-0-0).

Die Allergieanamnese war unauffällig bis auf eine Allergie gegen Novalgin, die sich in Engegefühl äußert.
Bei der Noxenanamnese erwähnte er lediglich ein Glas Rotwein pro Woche.

Die Familienanamnese ergab ein Bronchialkarzinom beim Vater (verstorben mit 60 Jahren), Morbus Parkinson bei der Mutter sowie ein Bronchialkarzinom beim Großvater (verstorben mit 65 Jahren).

Sozialanamnestisch ist er Tischlermeister, verheiratet und lebt in einer homosexuellen Beziehung; er hat eine adoptierte Tochter.

BEURTEILUNG

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Pneumonie hin.
Dyspnoe, produktiver Husten, ziehend-stechende Thoraxschmerzen, Fieber, Müdigkeit sowie eine ähnliche Erkrankung der Tochter vor einer Woche sprechen dafür.

Differentialdiagnostisch kommen Virale(Influenza, Covid-19) Pneumonie, Bronchitis, Bronchialkarzinom, Pneumokoniose, Pleuritis sowie ACS in Betracht.

PLAN

Zur Bestätigung der Verdachtsdiagnose werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen.
Bei der Auskultation suche ich nach feuchten Rasselgeräuschen.
Anschließend werde ich die Vitalparameter überwachen, ein EKG schreiben, um Herzrhythmusstörungen auszuschließen, und Blut für das Labor abnehmen.

Im Labor würde ich ein großes Blutbild, Entzündungsparameter (CRP, BSG, ggf. PCT), BGA(DANİSC'DE SÖYLEDİLER) Elektrolyte sowie Nieren- und Leberwerte bestimmen lassen. Zusätzlich würde ich eine Sputumkultur veranlassen.

Anschließend werde ich eine Röntgenaufnahme des Thorax in 2 Ebenen durchführen, ggf. ein CT-Thorax, und bei Bedarf ein Konsil in der Pulmonologie anfordern.

THERAPIE

Wenn sich die Verdachtsdiagnose bestätigt, kann der Patient zunächst ambulant behandelt werden; je nach Befunden ist jedoch eine stationäre Aufnahme zu erwägen.

Er sollte eine Infusionstherapie (Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution) sowie eine symptomatische Behandlung mit Analgetika, Antipyretika (z. B. Paracetamol), einem Mukolytikum (z. B. Acetylcystein) und Sauerstoffgabe über Nasensonde bei SaO_2 < 92 % erhalten.

Die Bettruhe wird empfohlen.

Ein Antibiotikum wie Amoxicillin/Clavulansäure wird verodnet. Je nach Ergebnisse der Sputumkultur kann das Antibiotikum geändert werden.

NOTLAR KENDİME

In der Regel wird vor Beginn der antibiotischen Therapie eine Kultur abgenommen, die Therapie wird jedoch empirisch begonnen und nach Vorliegen des Kulturergebnisses gegebenenfalls angepasst.

Die antibiotische Therapie wird je nach vermutetem Infektionsfokus empirisch begonnen und nach Erhalt der mikrobiologischen Ergebnisse gezielt angepasst.

💊 Sık enfeksiyonlarda ampirik antibiyotik (erişkin, toplum kökenli)

Enfeksiyon	İlk seçenek (empirik)	Alternatif
Toplum kökenli pnömoni (hafif)	Amoxicillin ± Clavulansäure	Doxycyclin / Makrolid
Toplum kökenli pnömoni (orta)	Amoxicillin/Clavulansäure + Azithromycin	Cefuroxim + Makrolid
Piyelonefrit	Ceftriaxon i.v. veya Ciprofloxacin p.o.	Piperacillin/Tazobactam
Basit sistit (kadın)	Nitrofurantoin	Fosfomycin
Komplike UTI	Ceftriaxon veya Piperacillin/Tazobactam	Meropenem (ESBL şüphesi)
Erysipel	Penicillin G veya Amoxicillin	Cefazolin
Selülit	Amoxicillin/Clavulansäure	Clindamycin
Akut tonsillit (bakteriyel)	Penicillin V	Amoxicillin
Akut otitis media	Amoxicillin	Amoxicillin/Clav
Sinüzit (bakteriyel)	Amoxicillin	Doxycyclin
Sepsis (odak bilinmiyor)	Piperacillin/Tazobactam i.v.	Meropenem
Menenjit (erişkin)	Ceftriaxon + Ampicillin	+ Vancomycin (direnç)

Pneumonie

- **Patient/ Patientin Datum (Vorname, Name, Geb.-Datum)**

Name: Jens Bergner / Niko Kroos / Tim Jelscht
Alter: 38 J. (geb. am 08.04.1986)
Größe: 1,73 m
Gewicht: 80 kg

- **Aufnahmegrund/ Diagnose (stichwortartig)**

Hauptbeschwerde:

- Seit 6 Tagen produktiver Husten mit gelblichem und grünem Auswurf.
- Seit 3 Tagen langsam aufgetretene, progrediente, ziehende, stechende und diffuse Brustschmerzen ohne Ausstrahlung.
- Seit 6 Tagen ziehende Schmerzen im Hals.
- Die Schmerzintensität: 6/10 auf der NRS
- Auslöser: Ähnliche Beschwerden bei seiner Tochter vor einer Woche.
- Lindernde Faktoren: Sitzen und Stehen
- Verstärkende Faktoren: Liegen
- Begleitsymptome:
  Dyspnoe (Bewegungsabhängig)

V/A:

- Fieber seit 3 Tagen (gestern 38,7°C, axillär)
- Schüttelfrost
- schmerzbedingte Dyssomnie
- gewollter Gewichtsverlust von 4 kg innerhalb der letzten 3 Monate
- Müdigkeit
- Inappetenz
- Covid-19-Schnelltest: negativ

V/E:

aHT seit 3 J. (kontrolliert, vor 4 T. 130/80 mmHg).

M:

Ramipril 5mg Tbl. 1-0-0

Vor-op:

Orchidopexie mit 11 Mon.
Appendektomie (App) mit 15 LJ.

- **Allergien/ Unverträglichkeiten:**

Novalgin (Engegefühl)

- **Genussmittel/ Drogen:**

- Nikotinkonsum: Nichtraucherin
- Alkoholkonsum: 1-2 Gl.Rotwein/W.
- Drogenkonsum: wurde verneint

- **Sozialanamnese:**

Tischlermeister
homosexuelle Beziehung
eine gesunde adoptierte Tochter (6J.)

- **Familienanamnese:**
  Vater, verst. an Bronchialkarzinom, mit 60 LJ.
  Großvater, verst. an Bronchialkarzinom, mit 65 LJ.
  Mutter (69 J.), Morbus Parkinson

- **Verdachtsdiagnose:**
  bakterielle Pneumonie

- **Differentialdiagnose**
  Virale Pneumonie
  Bronchitis
  Bronchialkarzinom

- **weitere Diagnostik**

- KU
- EKG
- Labor: großes BB - CRP - BSG - BZ - Leberwerte - Nierenwerte
- Sputumkultur
- Röntgen-Thorax
- Ggf CT-Thorax
- pneumologisches Konsil.

- **Therapievorschläge**

- Stationäre Aufnahme
- Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution
- Antipyretikum
- Analgetikum
- Antibiotikum (Ciprofloxacin)

- LTRA (Leukotrien-Rezeptor-Antagonisten): Montelukast
- Biologika / Anti-IgE-Antikörper: Omalizumab

Asthmaanfall

Symptome: veränderte Bewusstseinsebene, Arrhythmie, Zyanose, Fatigue / Erschöpfung, Hypotonie, Hypoxie, Tiffeneau-Index < 33%

Therapie:

- Den Patienten beruhigen, sitzende Körperhaltung
- O2: 2-4 L/min
- SABA: 2-4 Hübe
- Prednisolon 50-100mg **iv**
- *Ggf. Theophyllin 200 mg iv*
- *Ggf. Magnesiumsulfat iv*

22. Pneumonie (neuer Fall)

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

- Jens Bergner / Niko Kroos / Tim Jelscht *(jungen blonden Mann, deutlich, laut)*
- 38 J.
- *08.04.1986
- 1,73m
- 80kg

-Hauptbeschwerde

- Bestehende Husten Haben Sie Luftnot? Ist der Husten trocken oder mit Auswurf?
  - seit 6 Tagen
  - mit gelblichem und grünem Auswurf, ohne Blut
- Schmerzen im Hals Können Sie diese Schmerzen beschreiben?
  - seit 6 Tagen
- Brustschmerzen Haben Sie Brustschmerzen im Zusammenhang? Herzklopfen? Herzrasen?
  - seit 3 Tagen
  - langsam aufgetreten
  - persistierend
  - progredient
  - ziehend und stechend
  - ohne Ausstrahlung
  - Linderungsfaktor: sitzen und stehen
  - Verschlimmerungsfaktor: liegen
  - NRS: 6/10
- Dyspnö Tritt diese Luftnot bei Bewegung oder auch in Ruhe auf? Ist es schlimmer, wenn Sie sich hinlegen?
  - seit 3 Tagen
  - Bewegungs<u>un</u>abhängig
- Gab es in letzter Zeit jemanden in Ihrer Umgebung, der krank war?
  - Meine Tochter hatte vor einer Woche ähnliche Beschwerden, aber jetzt ist sie gesund.
  - Hat sie bei ihrem Arzt eine Diagnose erhalten? Bronchitis

-vegetative Symptomatik

- Fieber seit 3 Tagen (gestern 38,7°), Schüttelfrost
- Insomnie (wegen schmerzen)
- gewollte Gewichtsverlust von 4kg innerhalb von 3 Monaten
  - Wollten Sie Gewicht verlieren, oder war das ungewollt? Ja ich mache eine Wasserdiät
  - Woraus besteht die Wasserdiät? Ich trinke nur Wasser
  - Es ist nicht gut für Ihre Gesundheit, Ihre Körperzellen benötigen Energie und Nährstoffe, um richtig zu funktionieren. Ich kann Ihnen einen Diätassistenten empfehlen, wenn Sie abnehmen wollen
- Fatigue
- Covid 19- Schnelltest: negativ
- Inappetenz

-Vorerkrankungen

- aHT seit 3 Jahren (kontrolliert, einmal pro Woche, vor 4 Tage:130/80mmHg)
  - Haben Sie ein Messgerät zu Hause?
  - Es ist wichtig für Ihre Gesundheit, dass Sie Ihren Blutdruck täglich kontrollieren.

-Vor-OPs

Hoden kommt aus yukarı kanal kısaldı / almıştı

yani Hodensack'a inmemişti → Hoden forza yukarıda durur

- Leistenhoden (Kryptorchismus / Hodendystopie) mit 11 Monaten *(= Orchidopexie)*
  - ~~Warum ich musste wegen Leistenhoden operiert werden? Ist es sehr häufig?~~
  - Vor der Geburt befinden sich die Hoden im Bauchraum und sollen spätestens 12 Monaten nach der Geburt in den Hodensack absteigen. Wenn nicht gibt es Probleme wie Unfruchtbarkeit, Krebs oder Hodenverdrehung. Deshalb ist die Op notwendig.
  - Das kann häufig sein (1%), insbesondere bei frühgeborenen Kindern (20-30%).
- AE mit 15 LJ (Komplikationslos)

-Medikation

- Ramipril 5mg Tbl. 1-0-0 *(= Angiotensinkonversionsenzym-Hemmer)*

-Allergien

- Novalgin (Engegefühl) *(= Metamizol)*

-Noxen

- Alkoholkonsum: 1 Gl. Wein/ Wo
- Nikotin- und Drogenkonsum wurden verneint

-Sozialanamnese

- Beruf: Tischlermeister Wie sieht Ihre Arbeit aus? Sind Sie **Holzstaub ausgesetzt**?
  - ~~Kann ich Krankenschreibung bekommen? Seit drei Tagen kann ich nicht arbeiten.~~
  - Wir sollen noch mehr Untersuchungen machen, um die Diagnose zu stellen, und wenn sie bestätigt wird, könnte ich Ihnen ~~eine AU schreiben ja.~~ für heute eine Krankschreibung ausstellen, für die anderen Tage sollten Sie diese von Ihrem Hausarzt erhalten.
- Verheiratet, wohnt mi Ehemann zusammen / homosexuelle Beziehung
- 1 Tochter (adoptiert)
- Geimpft gegen Corona 3 mal

-Familienanamnese

"Für die weiteren Tagen wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt".

- Vater (60 J.): t an Bronchialkarzinom verstorben
- Opa (65 J.): t an Bronchialkarzinom verstorben
  - ~~Habe ich auch Lungenkrebs wie mein Vater und mein Opa? Ist es Erblich??~~
    - Ja Krebs hat eine erbliche Komponente. Ich glaube jedoch nicht, dass Sie Krebs haben, da Sie keine Symptome haben (z. B. Blut im Auswurf).
  - ~~Gibt es eine Möglichkeit dass ich auch Krebs in Zukunft haben werde?~~

Krebs verlauft oft still und schleichend.
(Sessiz ve sinsi)

(3)

- Ja wie alle Menschen eigentlich. Deshalb sollten Sie regelmäßig Ihren Hausarzt aufsuchen, um Ihren Gesundheitszustand zu überprüfen.

- Mutter (69 J.) Morbus Parkinson (Schüttellähmung)
  - ~~Was ist das? Was sind die Ursache dafür?~~
  - Das ist eine Krankheit, die zu **Zittern** und **Steifigkeit** führt. Die genauen Ursachen sind nicht ganz klar, aber es hat mit einem Mangel bestimmten chemischen Substanzen im Gehirn zu tun (Dopamine).

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, ich bin nun mit meinen Fragen fertig.
Ich habe einen Verdacht auf **Lungenentzündung**. Das ist nicht so schlimm und kann einfach mit Medikamenten behandelt werden. Aber das bleibt nur eine Vermutung, wir sollen weitere Untersuchungen durchführen, um dies zu bestätigen.
Ich werde zuerst Ihren Körper untersuchen, dann werde ich Ihnen etwas Blut abnehmen. Danach werden wir eine Röntgenaufnahme der Lunge machen. Wissen Sie, was das ist?

Röntgen ist ein medizinisches Verfahren zur bildlichen Darstellung von Körperstrukturen wie Knochen, Gefäßen und inneren Organen. Röntgenstrahlen gehen durch Ihre Lungen, um ein Bild zu erstellen. Eine tägliche Röntgenbelastung wäre gefährlich für Ihre Gesundheit, aber es gibt keine Gefahr, wenn Sie nur eine Radiologie pro Jahr durchführen lassen.

CT ist ein Röntgenbild, das viele Schichtaufnahmen von Ihrem Körper macht, um genauere Bilder von innen zu bekommen. Das ist schnell und schmerzfrei

Bronchoskopie: Bei einer Lungenspiegelung wird ein dünner Schlauch durch die Nase in die Lunge eingeführt, um die Atemwege von innen anzusehen. Machen Sie sich keine Sorge, Sie werden nichts spüren, wir machen bevor eine Allgemeinanästhesie / Vollnarkose.

-Fragen

- Ich habe Angst. Was habe ich? Was machen Sie für mich?
  - Sie haben wahrscheinlich eine Lungenentzündung, wir werden weitere Untersuchungen machen, um das zu bestätigen und Sie behandeln.
- Nächste Woche haben wir Urlaub. Kann ich reisen?
  - Es wäre besser, wenn Sie Ihre Reise verschieben, bis wir Ihre Diagnose geklärt haben und Sie sich besser fühlen.
  - Aber wir haben Flugtickets.
  - **Wenn Sie sich nächste Woche besser fühlen, können Sie reisen. Sie müssen jedoch Ihre Medikamente bis zum Ende der Behandlung weiter einnehmen.**
- Habe ich Corona?
  - Nein. Ich glaube nicht aber wir werden das trotzdem überprüfen
- Muss ich für Isolation zu Hause bleiben? Meine Schnell-Test ist negativ.
  - **48 Stunden nach der Einnahme des Antibiotikums sind Sie nicht mehr ansteckend, und Sie können das Haus verlassen.**
- Muss ich im KH bleiben? Momentan kann ich nicht wissen. Wir werden Ihre Befunde der Untersuchung, dann können wir entscheiden
  - Wenn mein Verdacht richtig ist, nein, können Sie nach den Untersuchungen nach Hause gehen.

Covid test: negativ →

Arzt-Arzt-Gespräch

Guten Tag. Mein Name ist Masson. Ich arbeite seit kurzem als Assistenzärztin in der Ambulanz/Notaufnahme.

Es geht um **Herr Jens Bergner, 38** Jahre alt, der in gutem AZ (Allgemeinzustand) und gutem EZ (Ernährungszustand) gekommen ist.

Er beschreibt seine aktuellen Symptome wie folgt: seit 6 Tagen bestehende Husten mit gelblichem und grünem **Sputum** (ohne Blut). Er berichtet auch seit 6 Tagen Halsschmerzen und seit 3 Tagen ziehende und stechende Brustschmerzen, die langsam aufgetreten sind und sind seitdem progredient, persistierend und ohne Ausstrahlung. Linderungsfaktoren sind sitzen und stehen. Und Verschlimmerungsfaktor ist liegen. 6 von 10 auf einer Schmerzskala. Er klagt auch seit 3 Tagen über bewegungsunabhängige Dyspnoe.

Er hat eine COVID-19-Schnell-Test gemacht, der Negativ war.

Er hat seit 3 Tagen Fieber, gestern war 38,7°, Schüttelfrost, Schmerzbedingte Insomnie und Inappetenz. Er hat gewollte Gewichtsverlust von 4 kg innerhalb 3 Monaten wegen einer Wasserdiät. **Ansonsten ist die vegetative Anamnese unauffällig.**

Er leidet seit 3 Jahren an arterielle Hypertonie und nimmt gelegentlich dagegen Ramipril 5mg ein.

Der Patient ist gegen Novalgin (= Metamizol) allergisch.

Der Patient ist Tischlermeister und daher **täglich Holzstaub ausgesetzt**.

In der Familienanamnese gibt es Bronchialkarzinom.

Das wäre zunächst dem Relevanten.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf bakterielle Pneumonie. An Differentialdiagnosen sind zu nennen, Virale Pneumonie, Bronchitis, Pneumokoniose, Bronchialkarzinom und ACS.

Als erstes werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen (bei der Auskultation: **Rasselgeräusche**); dann halte ich eine Laboruntersuchung mit Bestimmung: gr. BB, Entzündungsparameter, Leber-Nierenwerte, E-lyte, und **Sputumkultur**.

Anschließend ist ein **EKG**, und einen **Röntgen-Thorax in 2 Ebenen** durchzuführen.

Ich werde ihm **ambulant** behandeln.

Als initiale Therapie, empfehle ich Bettruhe, Analgetikum, Antipyretikum (Paracetamol) und **Schleimlösende** Medikament (= Mukolytikum: Acetylcystein), und O2-Gabe per Nasensonde bei Sa02 < 92%
Dann, bei kausaler Therapie, empfehle ich Antibiotikum (Amoxicillin + Clavulansäure) *mit präventivem Probiotikum.*

Sind Sie mit meinem /diesem Vorgehen einverstanden?

-Fragen

Was ist Ramipril? Ramipril ist einen ACE-Hemmer (= Angiotensinkonversionsenzym-Hemmer), eine Gruppe von Antihypertensiva (es gibt auch Diuretika = Furosemid, Betablocker = Metoprolol, Kalziumantagonisten = Nifedipin/Verapamil, AT1-Rezeptorantagonisten = Valsartan/Candesartan)
Angiotensin II - Typ-1 Rezeptorantagonisten

Was ist Leistenhoden? Behandlung? Name von chirurgische OP?

- Leistenhoden (= **Kryptorchysmus = Hodendystopie**): der Hoden befindet sich im Leistenkanal.
  - Vor der Geburt befinden sich die Hoden im Bauchraum, müssen aber vor 12 Monaten nach der Geburt in den Hodensack absteigen.
  - Wegen des Risikos der Infertilität (= Unfruchtbarkeit), des Krebses oder der Hodentorsion wird eine Operation durchgeführt.
- OP: **Orchidopexie** = operative Fixierung des Hodens im Skrotum

Was ist Tischlermeister? Handwerker, verantwortlich für die Planung, Herstellung und Reparatur von Möbeln und Holzarbeiten sowie für die Führung eines Tischlereibetriebs.

- Er ist also **Holzstaub ausgesetzt** und hat daher ein Risiko für Lungenfibrose oder Lungenkrebs

Was ist eine Pneumokoniose? = eine Lungenschädigung durch inhalierte Stäube:

- **Silikose** ▯ Quarzstaub (Bergbauer, Steinmetzbetriebe, Sandbetrieb)
- **Siderose** ▯ Eisenstaub
- **Asbestose** ▯ Asbest *(= Amiante)* (Bergbauer, Bauhandwerker)

Welche Typen von Lungenkrebs gibt es?

- Kleinzelliges Bronchialkarzinom (15%)
- Nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom (85%):
  - Plattenepithelkarzinom (Rauchen +++)
  - Adenokarzinom
  - Großzelliges Karzinom

Unterschiedlich zwischen bakterielle und virale Pneumonie?

- Bakterielle:
  - Ursache: Durch Bakterien wie Streptococcus pneumoniae oder Haemophilus influenzae.
  - Symptome: **Plötzlicher** Beginn mit **hohem Fieber**, Schüttelfrost, **produktivem Husten** mit gelb-grünlichem Sputum, Brustschmerzen.
  - Diagnose:
    - Röntgenaufnahme zeigt oft **konsolidierte Lungenareale. Lobärpneumonie** mit segmentaler Flächenschatten und Bronchopneumogramm (= Darstellung der Luftgefüllten Bronchioli mit heller Lungenparenchym)
    - Kulturen des Auswurfs können Bakterien nachweisen.
  - Behandlung: Antibiotika sind wirksam.
- Virale:
  - Ursache: Durch Viren wie Influenza, Respiratorisches Synzytialvirus (RSV) oder Coronavirus.
  - Symptome: **Langsameren** Beginn mit Fieber, **Husten, Muskelschmerzen** und **Erschöpfung**; Auswurf ist oft weniger ausgeprägt und kann **wässrig** sein.
  - Diagnose:
    - Röntgenaufnahmen zeigen oft **diffuse oder interstitielle Muster**
    - **Bronchopneumonie** = konfluierende Fleckschatten
    - Virustests oder PCR können den Virus nachweisen.
  - Behandlung: Meist symptomatische Behandlung; Antivirale Medikamente sind nur bei bestimmten Viren indiziert.

Welche Werte müssen erhöht falls VD gesichert? CRP und Leukozyten (Neutrophilen)

Was ist wichtig bei KU? Auskultation (Typisch sind **feuchte Rasselgeräusche**) Atemmuskulatur. Atemfrequenz.

Was ist unterschied mit Embolie in Auskultation?

- Pneumonie (Lungenentzündung):
  - **Feuchte Rasselgeräusche** durch Flüssigkeit in den Alveolen.
  - **Verminderte Atemgeräusche**: Über betroffenen Arealen aufgrund von Konsolidierung oder Flüssigkeitsansammlung.
  - **Vokale Fremitus**: Verstärkt, wenn der Arzt "99" sagt, kann über entzündete Bereiche besser gehört werden (Fremitus).
- Embolie (Lungenembolie): nicht spezifische
  - Kreppitationen: Gelegentlich, vor allem bei Begleitpleuritis oder Infarkt, aber weniger spezifisch.

- Atemgeräusche: Kann vermindert oder normal sein, abhängig von der Schwere der Embolie.
- **Schneller Herzschlag**: Oft begleitet von Tachykardie als indirektes Zeichen einer Embolie.

Nehmen Sie diesen Patienten stationär auf? Nein

<u>Labo (Frau Eckert: Hb 5.72)</u>

- **Akut**:
  - **Wie kann man bestätigen, ob das akut oder chronisch ist?** Erhöhte Retikulozyten spricht für Akute / Chronic = fast keine Symptome
  - **Was man als Behandlung tun soll?** Es hängt von den Ergebnissen ab. Eisentherapie / Transfusion
- **Chronisch**: Leukämien, aplastische Anämie, MDS

medizinische Maßnahmen

Was ist Iatrogenique, wissen Sie dass? Iatrogen bedeutet „**durch ~~einen Arzt~~ verursacht**" (iatros von greichisch = Arzt). Also durch Medikamente, Operationen usw.

Welchen Medikamenten?

- Chemotherapie ☐ N&V
- Glukokortikoiden ☐ Cushing-Syndrom
- NSAR ☐ Ulcus Ventriculi

<u>Über fall:</u>

Was werden Sie tun für Diagnose?

- Zuerst sollten die **vitalen Parameter** überprüft werden ggf. **Stabilisierung**
- Dann **KU mit Auskultation** erwarte ich abnormale Lungen Geräusche (= Rasselgeräusche)

Werden Sie ein CT-Untersuchung durchführen? Wenn nötig wird ja, aber **wir sollen Schritt zum Schritt weitermachen**: VP, KU, Labor, EKG, Rö-thorax, ...

Werden Sie Antibiotika verabreichen? Je nach allen Untersuchungen und Ergebnissen, man soll die Therapie planen. Die Ursache kann auch Viren, oder sogar Pilzen sein. Sogar es kann chemische Pneumonie sein. Wenn alles spricht für eine bakterielle Pnö man soll empirische AB anfangen, bis zum Kultur-Ergebnisse.

Denken Sie, dass die Tochter die gleiche Pneumonie hatte? Nein hier, es handelt sich wahrscheinlich um eine Virusinfektion mit Lungen-Superinfektion.

⇨ ***„Ich empfehle Ihnen auf Empathie sehr zu beachten. Bitte seien Sie natürlich nicht künstlich, verwenden Sie Ihre eigenen, originellen und nicht komplizierten Sätze."***

Ambulant wird meist Amoxicillin oder mit Risikofaktor (Alter, Lungen,) Amoxicilin / Clavulansäure empirisch gegeben.
~~stationäre~~ stationäre häufiger <u>Ampicillin / Sulbactam</u> oder Ceftriaxon ± Mozolid.

(1) Ambulante erworbene Pneumonie (AEP - CAP) — Eine Pneumonie, die außerhalb des Krankenhaus entsteht.
erreger — ~~Streptococcus~~ Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza

(2) Nosokomiale Pneumonie — (HAP) Eine Pneumonie, die >48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt.
erreger — Pseudomonas, MRSA,

Sonstige:

Labor zettel mit leukozytose 19.000 und CRP erhöht, was ist das? Geben Sie AB? Oder möchten Sie das ergebnis von Kultur zuerst sehen.

-Was ist Hepatomegalie?

Hepatomegalie bezeichnet eine Vergrößerung oder Schwellung der Leber

- **Ursachen**: Fettleber - Morbus Gaucher - Glykogeneinlagerungen z.B. bei Diabetes mellitus, Morbus von Gierke - Amyloidose – Hämosiderose - Extramedulläre Blutbildung – Neoplasien – Leukämien – Lymphome - Lebertumore, Metastasen - Budd-Chiari-Syndrom - Rechtsherzinsuffizienz - Hepatitis (Virushepatitis, AIH u.a.) - Leberzirrhose -Reye-Syndrom

-Was ist Splenomegalie?

Als Splenomegalie wird eine Vergrößerung der Milz bezeichnet.

- **Ursachen**: Milzvenenthrombose - Budd-Chiari-Syndrom - Leberzirrhose - Infektiöse Mononukleose - Tuberkulose - Malaria - HIV- Leukämien - Lymphome, Morbus Hodgkin - Myeloproliferative Syndrome (Primäre Myelofibrose, Polycythaemia vera) - Amyloidose - Morbus Gaucher

-Bei welcher Krankheit sehen wir eine Hepatosplenomegalie? (Malaria)

-Wo sehen wir Malaria am häufigsten? (ich sagte Afrika aber die Antwort war Nigeria.)

-Was ist External?

- Was bedeutet (Stero) ?

-wie viel Infusiontherapie es gibt? (1) Kristalloid (2) Kolloid (3) Blutprodukte (4) Parenteral Ernährung

-Was bedeutet Endokronologie ? Warum Endo ? und gibt es Exokrine Drüse? Wie z.B ? Und warum nennt als Exo ?

Abkürzung	
EBV	
CLL	Chronische lymphatische Leukämie
IVF	in vitro Fertilisation
LDL	

Morbus Gaucher → Glukosylceramidase Defekt

Morbus von Gierke → Glykogenose Typ I, Glukose 6 Phosphatase Defekt

Malaria → Parasiten infektion (Plasmodium) → ~~Afrika~~ Nigeria

Exokrine Drüsen geben ihre Sekrete über Ausführungsgänge nach außen oder in Körperhöhlen ab. im Gegensatz zu endokrinen Drüsen, die Hormone direkt ins Blut abgeben

(Kanäle)

(Kanälchen)

Exokrine Drüsen → Speicheldrüsen (Parotis, Sublingualis, Submandibularis)

→ Exokrine Pankreas (Glukagon, Insulin, Amylase)

→ Schweißdrüsen (Ekkrine, apokrine)

→ Talgdrüsen (Hautfett bzw.)

→ Milchdrüsen

Anamnesebogen - Ärztekammer Nordrhein – Fachsprachprüfung

Patient/ in

Nico Kroos

38 J. 2.1.1986

173 cm 80 kg

Datum

02.01.2026

(nur Stichpunkte) aktuelle Beschwerden

- Husten ~~mit Sputum (gelblich, grünlich, ohne Blut)~~ seit 6 Tagen bestehend
- mit Auswurf (Sputum) seit 3 Tagen (gelblich, grünlich ohne Blut)
- persistierend, progredient
- ~~Dyspnoe~~ Dyspnoe seit 6 Tagen, verschlimmernd bei Bewegung
- Brustschmerzen seit 3 Tagen, im ganzen Brust, ohne Ausstrahlung stechend, ziehend, persistierend, progredient, verschlimmernd bei Bewegung

Begleitsymptome

- Fieber seit 3 Tagen (gestern Abend 38,7°C axillär)
- Halsschmerzen seit 6 Tagen
- Gliederschmerzen
- schneller Covid-19 Test, 2-3 Mal, negativ
- Seine Tochter, vor 1 Woche, ähnliche Symptome

Vorerkrankungen

- aHT seit 3 Jahren
  (letzte Messung, vor 4 Tagen, 130/80) mmHg
  1 mal pro Woche

OP

- 2.n. Orchidopexie mit 11 Monaten
- 2.n. Appendektomie mit 15 J.
  komplikationslos

Vegetative Anamnese

- Inappetenz seit 6 Tagen
- Gewichtsabnahme von 4 kg in 3 Monaten, gewollt, Wasserdiät
- Schüttelfrost
- Hyperhydrose
- schmerzbedingte Dyssomnie

Medikamente

- Ramipril 5mg (1-0-0)

Anamnesebogen - Ärztekammer Nordrhein – Fachsprachprüfung

Allergien / Unverträglichkeiten

Novalgin (Unverträglichkeit)

Genussmittel

Nikotin → unauffällig
Alkohol → 1 Glas Rotwein pro Woche
Drogen → unauffällig

Sozialanamnese

- ~~[illegible]~~ Tischlermeister (mit Holzstaub ausgesetzt) seit 15-20 Jahren
- ~~Stress bei der Arbeit~~
- verheiratet
- hat eine Homosexuelle Beziehung
- eine Tochter ~~[illegible]~~ (adoptiert)

Impfung – vollständig

Familienanamnese

Vater: an Bronchialkarzinom mit 60 Jahre gestorben
Mutter → Morbus Parkinson
OPA → an Bronchialkarzinom mit 65 Jahre gestorben

Anamnesebogen - Ärztekammer Nordrhein – Fachsprachprüfung

(benutzen Sie Fachwörter, wo möglich) Verdachtsdiagnose

- Pneumonie

Differentialdiagnose

- Influenza
- Covid-19
- ~~Pneumokonyose~~ Bronchitis
- Bronchialkarzinom

weiteres Procedere

- KU (feuchte feine Rasselgeräusche)
- Vitalparameter, EKG
- Labor: gr BB, CRP, ggf. Prokalzitonin, Leberwerte, Nierenwerte, Elektrolytewerte, Herzenzyme, Sputumkultur, PCR
- Röntgen-Thorax
- ggf. CT-Thorax

Therapie

- ambulante Behandlung
- Bettruhe
- Analgetika
- ggf. Sauerstoffgabe (wenn SpO2 <92 ist)
- Antipyretika
- Antibiotika (~~Amoxicillin~~ Amoxicillin + Clavulanat) oder Clavulansäure
- Mukolytika
- ein Konsil in ~~Aachen~~ Pulmonologie
- ~~Patientenschulungen gegen Holzstaub~~